



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA



CENTRO DE INVESTIGACIÓN OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

INFORME TÉCNICO

Evolución demográfica de Costa Rica, 1994-2025

Fecundidad, estructura por edades, mortalidad, longevidad y envejecimiento

PROPÓSITO

Balance demográfico de largo plazo, verificación de alertas y prioridades públicas

FUENTES

Informes Estado de la Nación e indicadores oficiales del INEC

HORIZONTE

1994-2025, con escenarios a 2050

FECHA DE CORTE

Agosto de 2026

Documento dirigido a tomadores de decisión de política pública

MSI. Agustín Gómez Meléndez
Investigador del CIOdD

Contenido

Estructura principal del informe

Resumen ejecutivo	3
1. Propósito, alcance y método	5
2. Transformación demográfica de largo plazo	6
3. Población menor de 12 años	8
4. Población de 12 a 34 años	9
5. Población de 35 a 64 años	10
6. Población de 65 años y más	11
7. Personas centenarias	13
8. Natalidad, fecundidad y reproducción	14
9. Mortalidad y esperanza de vida	15
10. Balances quinquenales	17
11. Riesgos, oportunidades y alertas	19
12. Agenda estratégica 2026-2035	20
13. Sistema de seguimiento	22
14. Conclusiones	22
Referencias documentales	23
Anexo metodológico	24



Resumen ejecutivo

Costa Rica pasó en tres décadas de ser una sociedad relativamente joven, con crecimiento natural amplio y una fecundidad cercana a tres hijos por mujer, a una sociedad que envejece con rapidez, tiene fecundidad ultrabaja y se aproxima al cierre de su etapa de crecimiento poblacional. En 1994 el país tenía cerca de 3,4 millones de habitantes; 30,1% eran menores de 12 años, 40,3% tenían entre 12 y 34, 24,5% entre 35 y 64 y apenas 5,0% tenía 65 años o más. Para 2025, las estimaciones y proyecciones oficiales sitúan la población en aproximadamente 5,19 millones, pero la composición cambió: el grupo de 0 a 11 años bajó a 14,4%, el de 12 a 34 a 35,5%, el de 35 a 64 aumentó a 38,5% y la población de 65 años y más alcanzó 11,7%. El cambio principal no es solo que el país tiene más habitantes, sino que la niñez se redujo en términos absolutos y relativos, las cohortes jóvenes dejaron de expandirse y el peso demográfico se desplazó hacia edades medias y avanzadas.

La caída de la fecundidad constituye el motor del cambio. La tasa global pasó de aproximadamente 2,9 hijos por mujer en 1994 a un nivel cercano al reemplazo a inicios de la década de 2000. El Noveno Informe Estado de la Nación registró que en 2002 el país alcanzó una fecundidad de 2,09 hijos por mujer. Desde entonces la tasa continuó descendiendo. Las estadísticas vitales definitivas del INEC indican 1,12 hijos por mujer en 2024, 45.821 nacimientos y una tasa bruta de natalidad de 8,87 por mil habitantes. La tasa neta de reproducción fue cercana a 0,55 hijas por mujer, muy inferior al valor de uno que, bajo condiciones constantes, permitiría reemplazar una generación de mujeres por la siguiente. La fecundidad no solo está por debajo del reemplazo: desde 2020 se encuentra en la categoría de ultrabaja.

La reducción de nacimientos ofrece oportunidades de reorganización, pero no justifica recortes automáticos. Entre 1994 y 2025 la población de 0 a 11 años disminuyó de alrededor de 1,02 millones a 745.000. Este descenso reduce la demanda agregada de aulas, pediatría y servicios infantiles, pero la distribución territorial es desigual y persisten brechas de pobreza, nutrición, desarrollo temprano, cuidado y aprendizaje. El Estado puede utilizar la disminución de cohortes para elevar el gasto y la calidad por niño, reducir grupos, universalizar el cuidado y la educación preescolar y concentrar recursos en comunidades rezagadas. Si se responde únicamente cerrando servicios, el dividendo demográfico infantil se convertirá en una pérdida de capacidades.

El grupo de 12 a 34 años pasó de 1,37 millones en 1994 a un máximo cercano a 1,92 millones hacia 2014-2019 y luego empezó a disminuir. Para 2025 representa alrededor de 1,84 millones. Esta es la generación que sostiene la transición educativa, ingresa al mercado laboral, forma hogares y toma decisiones reproductivas. Su reducción futura no elimina los problemas juveniles; aumenta el costo de desaprovechar a cada persona. La exclusión educativa, el desempleo, la informalidad, el costo de la vivienda, la inseguridad económica y la desigual distribución de los cuidados afectan simultáneamente



productividad y fecundidad. Una política pronatalista aislada tendría poco efecto si no corrige las condiciones que hacen difícil estudiar, trabajar, emanciparse y criar.

La población de 35 a 64 años se convirtió en el grupo más grande. Aumentó de unas 833.000 personas en 1994 a casi dos millones en 2025, y su participación subió de 24,5% a 38,5%. Este grupo concentra experiencia laboral, ingresos, contribuciones tributarias y cotizaciones, pero también responsabilidades simultáneas de crianza y cuidado de personas mayores. Durante la próxima década su peso seguirá aumentando y será decisivo para financiar la transición. La oportunidad consiste en prolongar vidas laborales saludables, elevar productividad, prevenir enfermedades crónicas, actualizar competencias y eliminar barreras de empleo. El riesgo es llegar a la vejez después de trayectorias informales, con cotizaciones insuficientes, deterioro de salud y obligaciones de cuidado no remunerado.

La población de 65 años y más creció de aproximadamente 170.000 personas en 1994 a 606.000 en 2025. Su proporción pasó de 5,0% a 11,7%. Para 2050, las proyecciones oficiales la sitúan alrededor de 1,34 millones, casi una cuarta parte de la población. Las personas de 80 años y más pasarían de 33.000 en 1994 a 130.000 en 2025 y a cerca de 468.000 en 2050. Por eso el reto no es solamente financiar pensiones: es reorganizar salud, cuidados de larga duración, vivienda, movilidad, protección frente a la violencia patrimonial, participación social y prevención de dependencia. El Informe Estado de la Nación 2025 advierte que Costa Rica envejece más rápido que otros países latinoamericanos y que la oferta de cuidados es fragmentada, costosa y excluyente.

La longevidad es uno de los principales activos nacionales. La esperanza de vida pasó de unos 76,5 años en 1994 a 80,9 en 2024. El Décimo Informe documentó la extraordinaria supervivencia masculina a edades avanzadas y mostró que, a inicios del siglo, los hombres costarricenses de 80 años tenían una esperanza de vida superior a la observada en países con estadísticas confiables. La pandemia interrumpió temporalmente la tendencia: estimaciones citadas por el Informe 2021 calcularon pérdidas de esperanza de vida de dos años para hombres y 0,9 para mujeres bajo el período anual afectado. La recuperación posterior demuestra resiliencia, pero no elimina desigualdades por sexo, territorio, ingreso y acceso efectivo a servicios.

La mortalidad infantil resume avances y nuevas alertas. En 1994 se situaba cerca de 13 defunciones por mil nacimientos; bajó por debajo de diez a mediados de la década de 2000 y alcanzó valores cercanos a ocho durante la década de 2010. Sin embargo, la cifra definitiva de 2024 fue 10,21 por mil, el nivel más alto en aproximadamente veinte años según el Informe 2025. La reducción del número de nacimientos hace que variaciones pequeñas en defunciones produzcan tasas volátiles, pero el deterioro no debe descartarse como ruido estadístico. La mortalidad neonatal, la calidad del control prenatal, las brechas territoriales y el seguimiento de embarazos de alto riesgo requieren vigilancia reforzada.



La tasa bruta de mortalidad aumentará aunque la salud individual mejore, porque habrá más personas en edades donde la mortalidad es mayor. Pasó de alrededor de cuatro defunciones por mil habitantes en 1994 a 5,84 en 2024. Este aumento no debe interpretarse automáticamente como fracaso sanitario. La evaluación correcta combina mortalidad estandarizada por edad, esperanza de vida, años de vida saludable, mortalidad evitable y diferencias entre grupos. Sin este ajuste, el envejecimiento puede producir diagnósticos equivocados y decisiones presupuestarias mal orientadas.

La información sobre personas centenarias existe, pero exige cautela. Las proyecciones actualizadas en 2008 estimaron 231 personas de 100 años o más en 2000 y cerca de 800 en 2008, y calificaron a este grupo como el de crecimiento más rápido. Revisiones demográficas posteriores modificaron sustancialmente esas cifras. El kit oficial de estimaciones y proyecciones 1950-2100 publicado por el INEC en 2024 y actualizado en su plataforma proyecta alrededor de 324 personas centenarias en 2024, 346 en 2025 y 2.715 en 2050. La diferencia entre generaciones de estimaciones demuestra que los centenarios no deben presentarse como un conteo exacto: son una población pequeña, sensible a errores de edad, depuración registral, migración y revisión de supuestos. Aun así, su aumento es consistente con la expansión de la longevidad extrema.

El balance de política pública es claro. Costa Rica aprovechó una parte del bono demográfico para ampliar educación, salud, empleo femenino y cobertura social, pero no transformó plenamente esa ventana en productividad, formalidad y sostenibilidad. La razón de dependencia total descendió de 71 personas dependientes por cada cien en edad potencialmente activa en 1994 a cerca de 44 en 2025. Esa ventaja se agotará: hacia 2050 volvería a cerca de 58, pero con una composición inversa, dominada por personas mayores y no por niñez. El tiempo de preparación se acorta. La política demográfica debe articular educación, empleo, vivienda, salud reproductiva, igualdad de género, migración, pensiones y cuidados, y dejar de tratar el envejecimiento como un asunto exclusivo de asistencia social.

1. Propósito, alcance y método

Este informe analiza la evolución demográfica de Costa Rica desde el Primer Informe Estado de la Nación, referido a 1994, hasta el Informe 2025. Su público principal son autoridades y equipos técnicos responsables de educación, salud, trabajo, protección social, vivienda, planificación territorial, hacienda pública y gobiernos locales. El objetivo es explicar cómo cambiaron el tamaño, la composición y la dinámica de la población, qué oportunidades se abrieron, cuáles riesgos se materializaron y qué ajustes requiere la política pública.

La fuente interpretativa principal es la serie de Informes Estado de la Nación disponible en la carpeta de trabajo. Para reconstruir grupos de edad que no forman parte de las tabulaciones habituales se utiliza el kit oficial del INEC de estimaciones y proyecciones nacionales de población 1950-2100 por sexo y edad



simple. Para los hechos vitales recientes se privilegian las cifras definitivas de 2024 del INEC: nacimientos, natalidad, fecundidad, reproducción y mortalidad. Esta distinción es importante porque una proyección de población no sustituye el registro observado de nacimientos y defunciones.

Los rangos solicitados se convierten en categorías mutuamente excluyentes: 0 a 11 años; 12 a 34; 35 a 64; y 65 años o más. Esta convención evita contar dos veces a las personas de 35 y 65 años, pues los intervalos expresados originalmente compartían fronteras. El grupo de 65 años y más incluye subanálisis de 80 años y más y de 100 años y más. Cuando se comparan con datos publicados en los Informes que usan 0-14 y 15-64, se explicita la diferencia.

Las cifras de estructura por edad para 2024 y años posteriores corresponden a estimaciones o proyecciones, mientras los indicadores vitales definitivos de 2024 son observados. Las proyecciones cambian cuando se incorporan censos, correcciones de cobertura, nuevas pautas migratorias y hechos vitales. El Informe 2008 documentó que una revisión redujo la población estimada de ese año en cerca de 100.000 personas debido a menos nacimientos y menor migración que los previstos. Por eso este documento utiliza las proyecciones como escenarios de planificación, no como predicciones infalibles.

La evaluación quinquenal sigue la estructura adoptada en los informes técnicos CIOdD: identifica el punto de partida, los avances, los problemas, las alertas emitidas y su verificación en informes posteriores. En demografía, una advertencia puede tardar décadas en hacerse visible. La prueba retrospectiva permite establecer si la reducción de fecundidad, el agotamiento del bono, el envejecimiento, la presión sobre pensiones y la demanda de cuidados fueron sorpresas o riesgos conocidos que no recibieron respuesta suficiente.

2. La transformación demográfica de largo plazo

2.1 De expansión poblacional a crecimiento lento

En 1994 Costa Rica tenía aproximadamente 3,4 millones de habitantes y una tasa bruta de natalidad cercana a 23,6 por mil. Los nacimientos superaban los 80.000 anuales y la fecundidad rondaba 2,9 hijos por mujer. La población crecía tanto por el excedente de nacimientos sobre defunciones como por la migración. El Primer Informe ya señalaba que la caída de la fecundidad era desigual: los hogares pobres mantenían tasas sustancialmente mayores y las diferencias territoriales de mortalidad infantil mostraban que el promedio nacional ocultaba brechas.

Para 2024 la población alcanzó aproximadamente 5,16 millones, pero solo se registraron 45.821 nacimientos. El crecimiento natural fue 0,30 por cada cien habitantes. El número de nacimientos cayó cerca de 43% respecto a 1994 y la tasa de natalidad alrededor de 62%. La dinámica se aproxima al punto



en que las defunciones superarán a los nacimientos. La migración será entonces el componente principal que determine si la población continúa creciendo, se estabiliza o empieza a disminuir.

El cambio altera el significado de la planificación. Durante la expansión, la pregunta central era cómo ampliar rápidamente cobertura de escuelas, servicios de salud, vivienda y empleo. En la nueva etapa, el reto es redistribuir infraestructura entre territorios y edades, sostener servicios de calidad con cohortes pequeñas y financiar una población mayor creciente sin cargar desproporcionadamente a generaciones jóvenes menos numerosas.

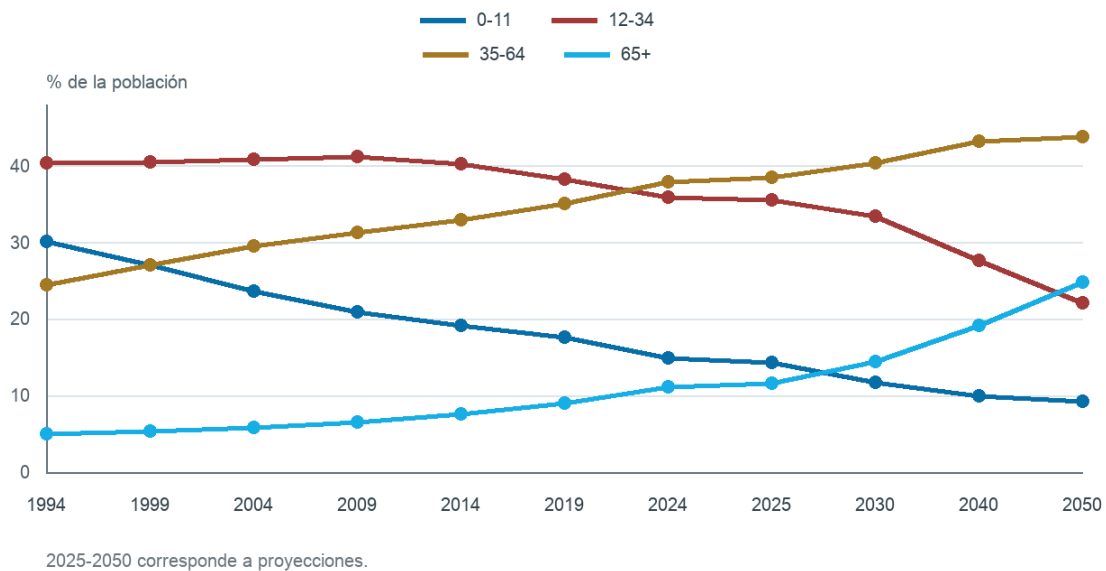


Figura 1. Participación de los grupos de edad solicitados

Fuente: elaboración propia con el kit de estimaciones y proyecciones nacionales del INEC.

2.2 El desplazamiento de la pirámide de edades

La estructura dejó de parecer una pirámide de base amplia. La población menor de 12 años perdió 15,8 puntos porcentuales entre 1994 y 2025. El grupo de 12 a 34 años alcanzó su máximo absoluto durante la década de 2010 y ya se contrae. Las edades de 35 a 64 se convirtieron en el centro demográfico, y las de 65 y más son las de crecimiento más rápido. La edad mediana aumentó de 21,7 años en 1994 a cerca de 33,9 en 2025 y podría superar 47 en 2050.

La razón de dependencia total cayó porque las cohortes infantiles disminuyeron antes de que aumentaran con fuerza las cohortes mayores. Esa combinación produjo el bono demográfico. En 1994 había aproximadamente 71 personas menores de 15 o mayores de 64 por cada cien de 15 a 64; en 2025 la razón ronda 44. Sin embargo, el indicador agregado oculta el cambio de composición. En 1994 predominaba la dependencia infantil; en el futuro dominará la dependencia de edades avanzadas, que demanda más salud, pensiones y cuidados prolongados.

2.3 Del bono demográfico a la economía de la longevidad

El bono no fue un ingreso automático. Para convertir una mayor proporción de población activa en crecimiento era necesario empleo formal, educación pertinente, ahorro, inversión, participación femenina y productividad. Los Informes documentaron avances en escolaridad y participación laboral, pero también desempleo estructural, informalidad y una desconexión creciente entre producción y empleo. El país llega al envejecimiento con una parte importante de su población laboral sin cotizaciones continuas y con brechas de ingreso que se reproducirán en la vejez.

La nueva etapa también abre oportunidades. La economía de la longevidad puede impulsar servicios de salud preventiva, tecnologías de asistencia, vivienda adaptada, movilidad accesible, turismo, aprendizaje permanente, empleo flexible y actividades comunitarias. Pero estas oportunidades no surgirán únicamente por el mercado. Requieren regulación, estándares de calidad, financiamiento y una política que reconozca a las personas mayores como sujetos de derechos, consumidores, trabajadores y productores de valor social.

3. Población menor de 12 años: menos niños, mayor obligación por niño

3.1 Contracción cuantitativa y distribución territorial

La población de 0 a 11 años pasó de cerca de 1,02 millones en 1994 a 745.000 en 2025. La disminución no fue lineal: se mantuvo alrededor de un millón hasta finales de los noventa y luego se aceleró conforme cayeron los nacimientos. Para 2050 las proyecciones la sitúan por debajo de 500.000. Esto reducirá la matrícula potencial de preescolar y primaria, pero los efectos aparecen primero en cantones de baja fecundidad o expulsión migratoria y más tarde en zonas con población joven o receptora de migrantes.

El Informe 2009 ya vinculaba el descenso de la natalidad con el cierre o reducción de escuelas en San José y Cartago y advertía que el MEP debía planificar territorialmente. La alerta se mantiene vigente. Un promedio nacional puede sugerir exceso de infraestructura mientras comunidades periféricas aún carecen de centros cercanos, transporte o servicios de cuidado. La reorganización debe basarse en cohortes por distrito, tiempos de traslado, pobreza y calidad de la planta física.



3.2 Mortalidad infantil y supervivencia

La reducción de la mortalidad infantil fue uno de los grandes logros del siglo XX y continuó durante buena parte del período. La tasa bajó de cerca de 13 por mil en 1994 a alrededor de ocho en la década de 2010. Esta trayectoria, junto con vacunación, atención primaria, agua potable y seguridad social, elevó la supervivencia y la esperanza de vida. No obstante, el aumento a 10,21 por mil en 2024 constituye una alerta. La mortalidad neonatal representó 7,33 por mil y la posneonatal 2,88.

La interpretación requiere dos precauciones. Con solo 45.821 nacimientos, cada defunción tiene mayor peso en la tasa. Además, la comparación anual puede ser volátil. Aun así, el deterioro simultáneo de la mortalidad infantil y de la niñez, que llegó a 11,59 por mil nacimientos en 2024, exige revisar control prenatal, prematuridad, malformaciones, acceso geográfico, calidad de atención y condiciones sociales de los hogares. Una población infantil más pequeña no garantiza mejores resultados si la inversión y la prevención se debilitan.

3.3 Implicaciones para educación, cuidado y equidad

La menor cantidad de niños ofrece una oportunidad histórica para universalizar servicios de alta calidad. La respuesta óptima no es reducir gasto en la misma proporción que la matrícula. Debe aumentar la intensidad por persona: detección temprana de rezagos, nutrición, salud mental, educación inicial, jornada ampliada, apoyo a discapacidad, conectividad y protección. La fecundidad ultrabaja aumenta el valor social de cada trayectoria educativa perdida.

También cambia la relación entre cuidado y empleo femenino. Cuando los servicios son insuficientes, la responsabilidad recae en hogares y principalmente en mujeres. Esta carga reduce participación laboral e ingresos y puede desincentivar la maternidad. Una red de cuidado infantil accesible cumple tres funciones: protege derechos de la niñez, mejora la inserción laboral femenina y reduce el costo privado de formar una familia.

4. Población de 12 a 34 años: una cohorte que deja de expandirse

4.1 Del crecimiento al máximo demográfico

El grupo de 12 a 34 años creció de 1,37 millones en 1994 a cerca de 1,92 millones en 2014-2019. Su peso se mantuvo alrededor de 40% durante dos décadas, pero bajó a 35,5% en 2025. Hacia 2050 podría representar apenas 22,1% de la población. Esta contracción modifica la demanda de secundaria, educación superior, primer empleo, alquiler, vivienda y salud sexual y reproductiva.



Durante la expansión juvenil el país no logró integrar a todas las personas. Los Informes señalaron repetidamente la exclusión de secundaria, la población que no estudia ni trabaja, el desempleo juvenil y la informalidad. Estas fallas adquieren mayor gravedad cuando las cohortes disminuyen. Un joven excluido ya no puede ser sustituido demográficamente por una generación más grande detrás; representa una pérdida más costosa de capital humano, productividad y base contributiva.

4.2 Formación de hogares y fecundidad

Las decisiones reproductivas ocurren en un contexto de educación prolongada, inserción laboral tardía, vivienda costosa, empleos inestables y desigualdad de género. El Informe 2025 relaciona las barreras laborales de las mujeres y la penalización por maternidad con el descenso de la fecundidad. No es correcto interpretar 1,12 hijos por mujer únicamente como una preferencia privada. La cifra también refleja condiciones institucionales que separan el deseo de tener hijos de la posibilidad material de hacerlo.

Una política respetuosa de derechos no fija metas obligatorias de natalidad. Busca que las personas puedan realizar sus preferencias reproductivas, tengan o no hijos. Esto requiere acceso a salud sexual y reproductiva, prevención del embarazo no intencional, corresponsabilidad masculina, licencias parentales, cuidado, vivienda, horarios compatibles y estabilidad laboral. Los incentivos monetarios de corta duración suelen ser insuficientes frente al costo acumulado de crianza y la incertidumbre.

4.3 Migración como componente demográfico

Con crecimiento natural bajo, la migración adquiere mayor importancia. En los noventa la inmigración nicaragüense contribuyó al crecimiento, la fuerza de trabajo y la diversidad; el Décimo Informe registró que la población extranjera pasó de 3,7% en 1984 a 7,8% en 2000. Las revisiones de 2008 mostraron, sin embargo, que los flujos pueden desviarse de las proyecciones: entre 2001 y 2007 llegaron aproximadamente 70.000 migrantes menos de lo esperado.

La política migratoria debe integrarse a la planificación demográfica. La migración puede moderar la reducción de población joven y trabajadora, pero no sustituye reformas de productividad, formalidad e integración. La regularización, el reconocimiento de competencias, el acceso a servicios y la prevención de discriminación determinan si el flujo amplía capacidades o reproduce vulnerabilidad.



5. Población de 35 a 64 años: centro productivo y generación de cuidados

5.1 El grupo de mayor crecimiento absoluto

Entre 1994 y 2025 el grupo de 35 a 64 años aumentó en aproximadamente 1,16 millones de personas. Su participación creció catorce puntos porcentuales y en 2024 superó por primera vez, bajo los cortes utilizados aquí, al grupo de 12 a 34. Hacia 2040 podría concentrar más de 43% de la población. Esta es la última gran cohorte del bono demográfico y la principal fuente potencial de impuestos, cotizaciones, ahorro y experiencia.

Su tamaño crea una ventana breve para fortalecer las finanzas de la transición. Elevar formalidad y productividad durante los próximos diez a quince años tendrá efectos acumulativos sobre pensiones futuras, demanda de asistencia y sostenibilidad fiscal. Lo contrario también se acumula: una persona de 50 años en empleo informal tiene poco tiempo para construir una pensión contributiva suficiente.

5.2 Salud preventiva y envejecimiento saludable

Las enfermedades crónicas, la obesidad, la salud mental y las limitaciones funcionales se forman antes de los 65 años. Una política de envejecimiento que empieza con la jubilación llega tarde. Los servicios de salud deben intensificar prevención, diagnóstico temprano, rehabilitación y promoción de actividad física en edades medias. Las empresas necesitan adaptar puestos, formación y jornadas para retener experiencia sin deteriorar salud.

La esperanza de vida no equivale a años libres de dependencia. Si la longevidad aumenta sin mejorar la salud funcional, crecerán hospitalizaciones, cuidados y gasto de bolsillo. El indicador estratégico es la esperanza de vida saludable y la prevalencia de dependencia por edad, no solo la supervivencia.

5.3 La generación sándwich

Muchas personas de 35 a 64 atienden simultáneamente hijos y padres mayores. La reducción del tamaño familiar significa menos hermanos entre quienes distribuir el cuidado. El modelo basado en trabajo femenino no remunerado será cada vez menos viable, porque también se espera mayor participación de las mujeres en el empleo formal. La ausencia de servicios de larga duración puede expulsar trabajadores del mercado, reducir cotizaciones y agravar la misma sostenibilidad que intenta proteger.



6. Población de 65 años y más: envejecimiento acelerado y diversidad interna

6.1 Crecimiento y feminización

La población de 65 años y más aumentó más de tres veces y media entre 1994 y 2025. No es un grupo homogéneo. Las personas de 65 a 79 suelen mantener mayor autonomía y participación, mientras el crecimiento de 80 años y más eleva la probabilidad de dependencia. Las mujeres sobreviven más, pero pueden llegar a la vejez con menores pensiones por interrupciones laborales, salarios inferiores y trabajo de cuido no remunerado.

El índice de envejecimiento -personas de 65 y más por cada cien menores de 15- pasó de 13,6 en 1994 a una proyección de 62,2 en 2025. Podría acercarse a 92 en 2030 y superar 212 en 2050. Esto significa que a mediados de siglo habría más de dos personas mayores por cada menor de 15. La transformación afectará la representación política, el consumo, la organización territorial y las prioridades presupuestarias.

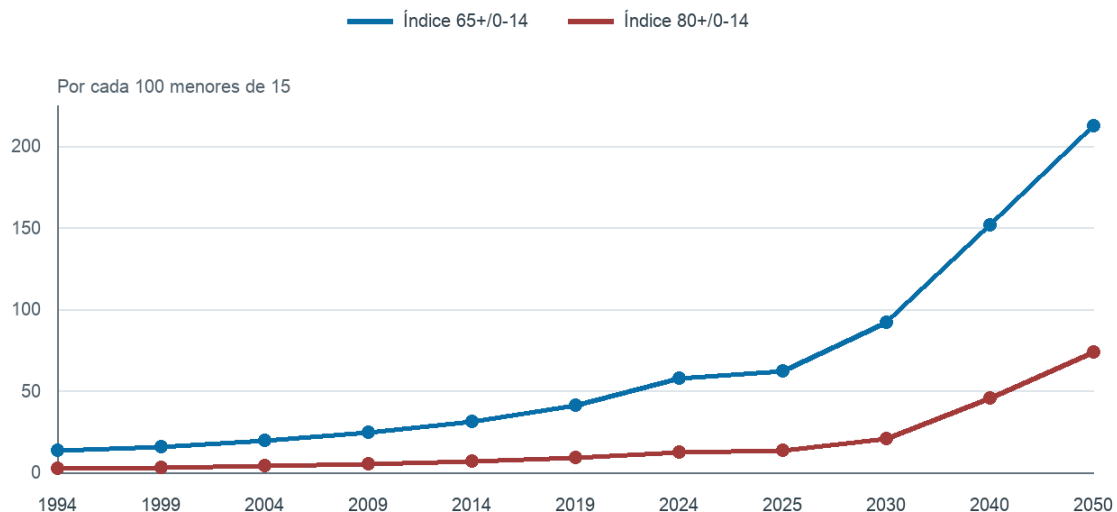


Figura 2. Índices de envejecimiento y sobre-envejecimiento

Fuente: elaboración propia con estimaciones y proyecciones del INEC.

6.2 Pensiones y protección económica

El aumento de la población mayor incrementa beneficiarios potenciales mientras el crecimiento de cotizantes se desacelera. La sostenibilidad depende de edad de retiro, densidad de cotización, salarios, informalidad, rentabilidad, aportes y cobertura. Reducir el problema a una sola variable puede trasladar

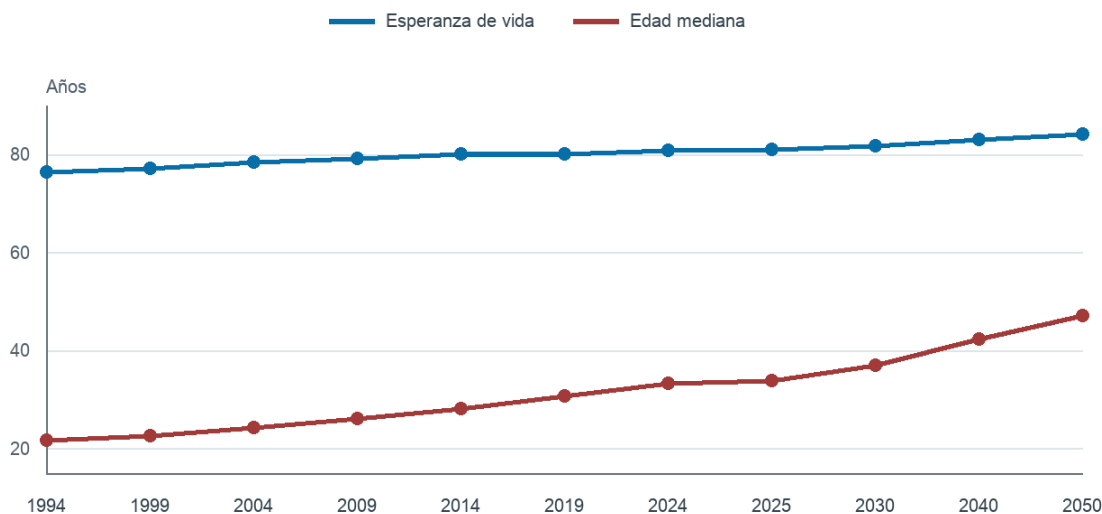
costos de manera regresiva. Una edad uniforme de jubilación, por ejemplo, ignora diferencias de esperanza de vida saludable, ocupación y trayectoria contributiva.

Los Informes advirtieron desde inicios de siglo que la transición demográfica presionaría los regímenes. La ventana para reformas graduales era amplia, pero se estrechó. La respuesta debe combinar sostenibilidad actuarial, pensión mínima, ampliación de cotizantes, formalización, equidad entre regímenes y protección no contributiva para quienes llegan a la vejez sin historial suficiente.

6.3 Salud, dependencia y cuidados de larga duración

El Informe 2025 estima que la prevalencia de discapacidad alcanza 37,4% entre las personas de 65 años y más. La Política Nacional de Cuidados 2021-2031 y la Ley 10.192 crearon una base institucional, pero la oferta continúa fragmentada. Un centro de día privado tenía un costo promedio cercano a 436.000 colones mensuales y una residencia privada alrededor de 804.000, montos inaccesibles para gran parte de los hogares.

El desafío de financiamiento no puede posponerse hasta que aumente la demanda. Deben definirse prestaciones, criterios de dependencia, estándares, personal, fuentes de recursos, copagos progresivos, apoyo domiciliario y protección de cuidadores. La prevención de dependencia puede reducir costos futuros, pero no elimina la necesidad de un sistema formal.



La esperanza de vida de 2024 coincide con el Informe 2025; años futuros son proyecciones.

Figura 3. Esperanza de vida al nacer y edad mediana

Fuente: INEC y Programa Estado de la Nación.

7. Personas centenarias y longevidad extrema

La serie ofrece evidencia específica sobre personas de 100 años y más. En 2008, una actualización de proyecciones estimó 231 centenarios en 2000 y cerca de 800 en 2008. También señaló que era el grupo de crecimiento más rápido. El Décimo Informe había documentado la longevidad excepcional de hombres costarricenses a edades de 80 y 90 años y una relación entre mujeres y hombres centenarios mucho menos desequilibrada que en otros países.

Las revisiones posteriores obligan a interpretar aquellas cifras con prudencia. El kit oficial vigente estima aproximadamente 324 personas de 100 años y más en 2024 y 346 en 2025; para 2050 proyecta alrededor de 2.715. La estimación actual para 2008 es muy inferior a la publicada en 2008. Las diferencias pueden provenir de corrección de edades, calidad censal, registros tardíos y nuevos modelos de supervivencia. No es metodológicamente válido unir sin advertencia las cifras de distintas revisiones.

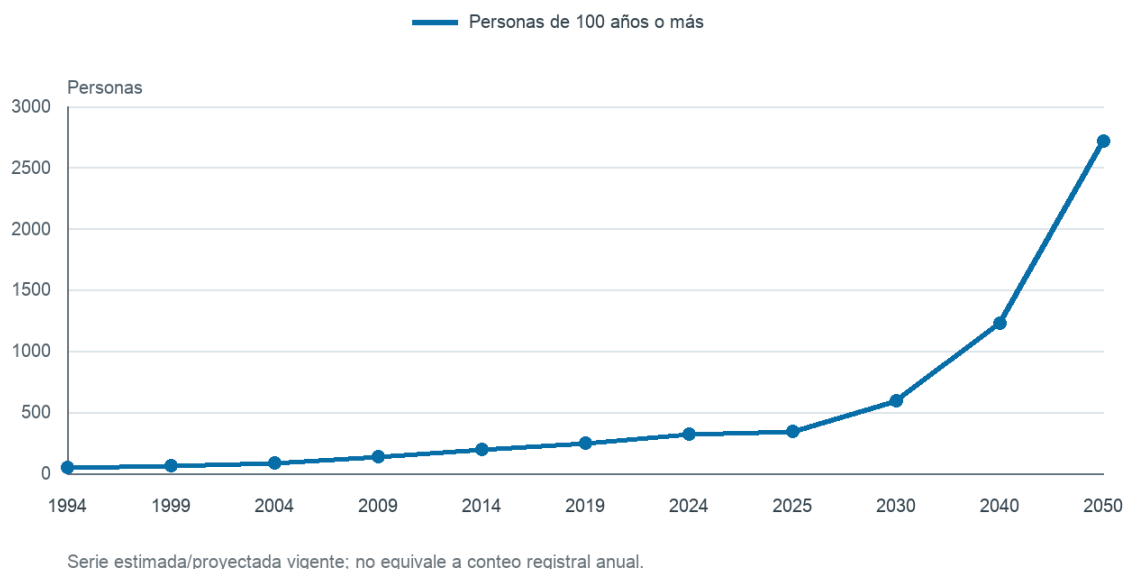


Figura 4. Personas de 100 años o más, estimadas y proyectadas

Fuente: elaboración propia con el kit vigente de proyecciones del INEC.

La importancia de este grupo no reside en su peso actual, inferior a una centésima de la población, sino en lo que revela sobre longevidad extrema y necesidades especializadas. Las personas centenarias requieren seguimiento de funcionalidad, redes familiares, vivienda, cuidados, protección patrimonial y causas de supervivencia. El país debería construir una estadística anual validada que distinga personas registradas, residentes y proyectadas, y que permita estudiar desigualdades de longevidad.

8. Natalidad, fecundidad y reproducción

8.1 Del reemplazo a la fecundidad ultrabaja

La tasa global de fecundidad descendió de 2,9 en 1994 a aproximadamente 2,1 en 2002-2004. La tasa de reemplazo no es una frontera mágica: depende de mortalidad y composición por sexo, pero suele situarse alrededor de 2,1 hijos por mujer. El paso por ese nivel fue reconocido como un hito positivo de la transición demográfica. El problema no fue alcanzarlo, sino continuar descendiendo sin adaptar instituciones.

En 2014 la tasa era 1,78; en 2019, 1,56; en 2020, 1,41; en 2022, 1,30; en 2023, 1,22; y en 2024, 1,12. La tasa bruta y neta de reproducción bajaron a cerca de 0,55 hijas por mujer. Si estos niveles persistieran y no hubiera migración, cada generación sería sustancialmente menor que la anterior. La estructura todavía conserva inercia porque cohortes grandes atraviesan edades reproductivas y laborales, pero la base ya se contrajo.

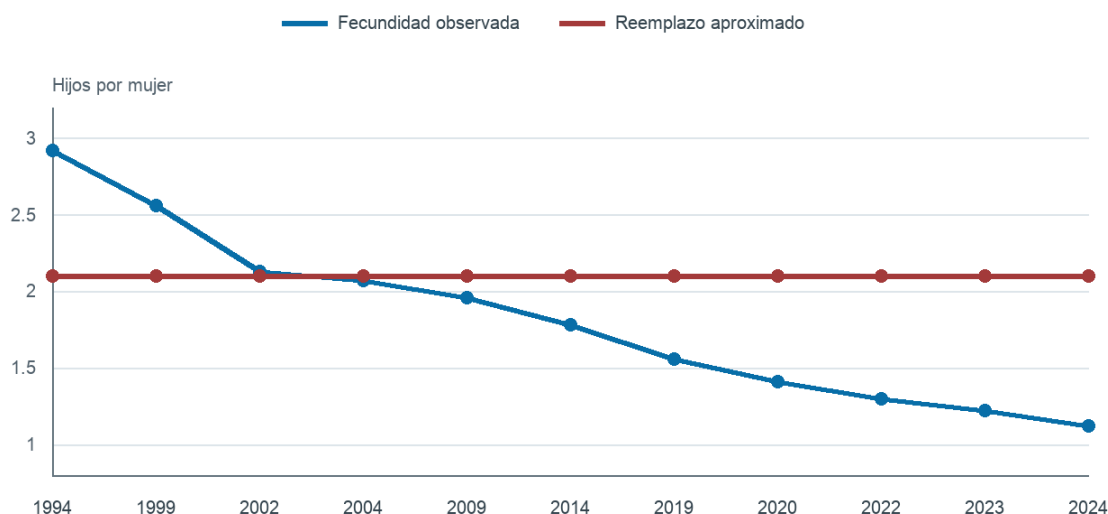


Figura 5. Tasa global de fecundidad y nivel de reemplazo

Fuente: INEC; Informes Estado de la Nación.

8.2 Causas y respuestas posibles

La caída combina educación femenina, acceso a anticoncepción, urbanización, postergación de uniones y maternidad, cambio de preferencias, costo de vivienda, inestabilidad laboral y desigual distribución de cuidados. Algunos factores representan libertad y desarrollo; otros reflejan restricciones. Por ello, no toda baja fecundidad debe considerarse negativa ni toda política para elevar nacimientos es deseable.

El objetivo público debe ser reducir la brecha entre fecundidad deseada y realizada, proteger derechos reproductivos y eliminar penalizaciones por maternidad y paternidad. Los servicios de cuidado, las licencias, la vivienda y el empleo estable tienen efectos más estructurales que transferencias únicas. También es necesario reconocer que aun con políticas exitosas la fecundidad puede permanecer baja; los sistemas deben adaptarse a ese escenario.

9. Mortalidad, esperanza de vida y transición epidemiológica

9.1 Una vida más larga

La esperanza de vida aumentó aproximadamente 4,4 años entre 1994 y 2024. La ganancia es menor que en décadas previas porque el país ya partía de un nivel alto. Las mejoras adicionales dependen menos de controlar enfermedades infecciosas y más de prevenir y tratar enfermedades crónicas, accidentes, violencia, salud mental y desigualdades territoriales.

La brecha por sexo persiste. Las proyecciones oficiales para 2026 sitúan la esperanza de vida en 78,68 años para hombres y 83,69 para mujeres. La mayor mortalidad masculina se relaciona con causas externas, riesgos laborales, estilos de vida y uso tardío de servicios. Una política demográfica debe evitar que el promedio oculte años perdidos prevenibles.

9.2 La pandemia como choque demográfico

La covid-19 elevó defunciones y redujo temporalmente esperanza de vida. El Informe 2021 estimó una reducción de dos años para hombres y 0,9 para mujeres durante el período afectado si las condiciones se mantuvieran. La vacunación redujo la mortalidad y la esperanza de vida se recuperó. El episodio mostró que los avances de longevidad no son irreversibles y que las emergencias afectan de forma distinta según edad, sexo y posición social.

9.3 Mortalidad general y efecto de composición

La tasa bruta de mortalidad subió de 4,31 por mil en 2014 a 5,84 en 2024. Parte importante del aumento responde al envejecimiento. Para evaluar desempeño sanitario deben emplearse tasas estandarizadas, mortalidad prematura y evitable. De lo contrario, un cantón envejecido puede parecer menos saludable solo por su composición y uno joven puede ocultar riesgos elevados.



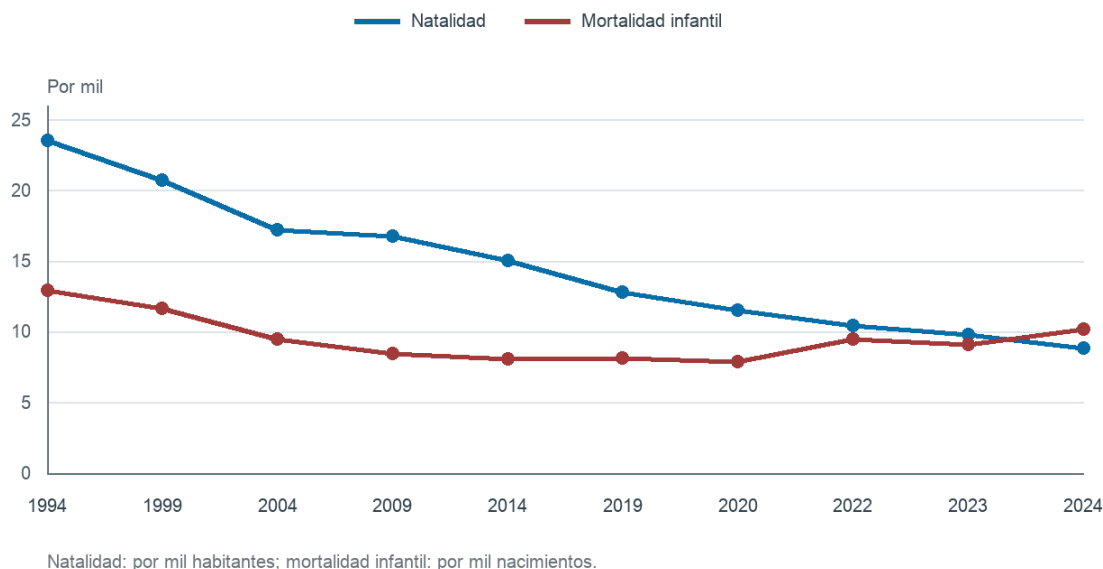


Figura 6. Tasas de natalidad y mortalidad infantil

Fuente: INEC; Informes Estado de la Nación.

10. Balances quinquenales y verificación retrospectiva

10.1 1994-1998: población joven y primeras señales de envejecimiento

El primer quinquenio empezó con fecundidad cercana a tres hijos, más de 80.000 nacimientos y 30% de la población menor de 12 años. Los avances fueron una esperanza de vida elevada, mortalidad infantil baja para el nivel de ingreso y expansión de la seguridad social. Las debilidades se concentraban en brechas territoriales y socioeconómicas de fecundidad, mortalidad infantil y acceso a servicios.

Los informes ya identificaron descenso de fecundidad, aumento de longevidad y envejecimiento. La alerta se confirmó. Para 1999 la población menor de 12 había bajado a 27%, la edad mediana subió y la población mayor crecía. Sin embargo, la agenda pública continuó orientada principalmente a expansión de coberturas, con poca anticipación de pensiones, cuidados y reorganización territorial.

10.2 1999-2003: se alcanza el reemplazo

Este período marcó el punto de inflexión. La fecundidad llegó a 2,09 en 2002 y la esperanza de vida superó 78 años. La menor natalidad amplió el bono demográfico y redujo la dependencia infantil. La oportunidad era invertir más por niño, elevar secundaria y formalizar una fuerza laboral creciente.

Los informes advirtieron que la transición exigía preparar pensiones y servicios para mayores. La advertencia fue correcta, pero la respuesta fue parcial. La cobertura educativa mejoró, aunque persistió exclusión; la formalidad no avanzó al ritmo necesario y las reformas de cuidados quedaron pendientes.

El bono se aprovechó en expansión económica, pero no se convirtió plenamente en ahorro social y productividad.

10.3 2004-2008: revisiones estadísticas y evidencia de longevidad

La fecundidad se ubicó por debajo del reemplazo y la mortalidad infantil bajó. La revisión demográfica de 2008 mostró 30.000 nacimientos y 70.000 migrantes menos de lo proyectado entre 2001 y 2007. La población estimada fue 2,2% menor. El episodio evidenció que la planificación basada en proyecciones debe actualizarse con rapidez.

También surgió información sobre centenarios y longevidad excepcional. La oportunidad era crear sistemas de información para edades avanzadas y cuidados. En años posteriores las cifras de centenarios fueron revisadas, pero la tendencia de crecimiento extremo permaneció. El riesgo no era la precisión de un número pequeño, sino la falta de preparación para una supervivencia prolongada.

10.4 2009-2013: cae la niñez y se hace visible la presión de salud

En 2009 la fecundidad era 1,96 y la población menor de 12 representaba 20,9%. El Informe vinculó la menor natalidad con cambios en matrícula y centros educativos. En 2012 la mortalidad infantil alcanzó entonces un mínimo histórico de 8,5 por mil. El Informe 2013 proyectó que el grupo mayor de 65 se duplicaría y advirtió impactos en recursos humanos, infraestructura y financiamiento de salud.

La verificación posterior confirma la alerta: las personas mayores pasaron de 294.000 en 2009 a 576.000 en 2024. La adaptación institucional fue más lenta. Se expandieron programas y discusión pública, pero no se consolidó un sistema suficiente de cuidados ni una reforma integral de financiamiento.

10.5 2014-2018: envejecimiento sostenido y ventana laboral todavía favorable

La fecundidad descendió de 1,78 a 1,66. La proporción de 35 a 64 aumentó y la dependencia total llegó a sus niveles más bajos. Fue una etapa favorable para elevar empleo formal, cotización y ahorro. La esperanza de vida se mantuvo alrededor de 80 años.

El riesgo era confundir una razón de dependencia baja con sostenibilidad garantizada. El empleo informal y las brechas femeninas limitaron cotizaciones. La inversión social empezó a enfrentar rigideces fiscales. Los informes posteriores mostraron que el bono se acercaba a su fin sin que se hubieran resuelto productividad y cobertura contributiva.

10.6 2019-2023: fecundidad ultrabaja, pandemia y fin del bono

La fecundidad pasó de 1,56 en 2019 a 1,22 en 2023. La pandemia elevó mortalidad, redujo temporalmente esperanza de vida y afectó empleo, educación y salud. Los Informes declararon el



agotamiento del primer bono demográfico y advirtieron que el envejecimiento agregaría presión fiscal y social a una recuperación desigual.

En 2021 se aprobó la Política Nacional de Cuidados y en 2022 se creó el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos. Estos fueron avances institucionales. La verificación de 2025, sin embargo, muestra cobertura limitada, costos altos y financiamiento insuficiente. El riesgo identificado se materializó más rápido que la capacidad operativa.

10.7 2024-2025: caída récord de nacimientos y alerta en mortalidad infantil

En 2024 se registraron 45.821 nacimientos, fecundidad de 1,12 y natalidad de 8,87 por mil. La mortalidad infantil aumentó a 10,21 y la general a 5,84. La población de 65 años y más superó 11% y la de 0 a 11 bajó a menos de 15%. El país entró en una fase donde envejecimiento y contracción de cohortes infantiles ocurren simultáneamente.

La oportunidad es actuar con evidencia antes de que la dependencia de mayores se acelere en la década de 2030. La alerta es que la restricción fiscal produzca recortes lineales en educación, salud y cuidados precisamente cuando se requiere reasignación estratégica. El período no puede evaluarse solo por el tamaño de la población, sino por la capacidad de garantizar trayectorias saludables y productivas con menos nacimientos y más longevidad.

11. Riesgos, oportunidades y alertas para la decisión pública

11.1 Riesgo de ajuste fiscal demográficamente ciego

El envejecimiento presiona pensiones, salud y cuidados, pero reducir inversión en niñez y juventud sería contraproducente. Cohortes menores deben ser más productivas y saludables para sostener la transición. El presupuesto necesita proyecciones generacionales que distingan gasto corriente, inversión preventiva y pasivos futuros.

11.2 Riesgo de cierre territorial indiscriminado

La caída de matrícula puede justificar fusiones o cambios de uso, pero no debe aumentar tiempos de traslado ni abandonar territorios rurales. Cada decisión de infraestructura educativa y sanitaria debe usar proyecciones por distrito, accesibilidad y escenarios migratorios.



11.3 Riesgo de reproducir el cuidado femenino no remunerado

La demanda crecerá mientras disminuye el tamaño de las familias. Si el Estado supone que los hogares absorberán el cuidado, caerá la participación laboral femenina, aumentará el empobrecimiento de cuidadores y se debilitarán cotizaciones. Este es un riesgo económico, fiscal y de igualdad.

11.4 Oportunidad de invertir más por persona menor de edad

Menos niños permiten universalizar calidad sin expansión física masiva. La prioridad debe ser primera infancia, aprendizaje, nutrición, salud mental, jornada ampliada y reducción de desigualdad territorial. El indicador no es cuánto se ahorra por menor matrícula, sino cuánto mejora cada resultado.

11.5 Oportunidad de prolongar vida saludable y productiva

La cohorte de 35 a 64 es numerosa y tiene experiencia. Capacitación, flexibilidad laboral, prevención y adaptación de puestos pueden elevar productividad y retrasar dependencia. Las políticas no deben asumir que toda persona mayor es inactiva ni que toda prolongación laboral es posible sin ajustes.

11.6 Alerta sobre fecundidad y libertades reproductivas

La ultrabaja fecundidad requiere análisis, no coerción. La respuesta debe reducir obstáculos a los proyectos familiares sin debilitar anticoncepción, autonomía o participación femenina. El éxito se mide por la posibilidad de realizar preferencias y por el bienestar infantil, no por una cuota de nacimientos.

12. Agenda estratégica 2026-2035

12.1 Crear un marco nacional de planificación demográfica

La planificación debe actualizar anualmente nacimientos, defunciones, migración y estructura por edad, y traducirlos en demanda territorial de servicios. Hacienda, Mideplan, INEC, CCSS, MEP, IMAS, municipalidades y universidades requieren escenarios comunes y trazables.

12.2 Reorganizar servicios para cohortes infantiles menores

La reducción de matrícula debe financiar calidad, no convertirse automáticamente en recorte. Los centros pueden transformarse en nodos de primera infancia, jornada ampliada, alimentación, cultura y apoyo comunitario. Toda reorganización debe evaluar accesibilidad y equidad.



12.3 Reducir el costo de formar hogares y criar

Una agenda integral debe ampliar cuido, licencias, corresponsabilidad, vivienda asequible, transporte y estabilidad laboral. La política debe reconocer la diversidad de hogares y respetar decisiones reproductivas.

12.4 Aprovechar la última fase del bono laboral

La prioridad inmediata es formalizar y capacitar a la población de 35 a 64, elevar participación femenina y recuperar jóvenes excluidos. Cada empleo formal creado hoy mejora ingresos, recaudación y pensión futura.

12.5 Financiar cuidados de larga duración

El Sinca necesita cartera de prestaciones, metas de cobertura, costos unitarios, mecanismos de copago progresivo, acreditación y financiamiento plurianual. Deben priorizarse servicios domiciliarios y comunitarios que preserven autonomía, sin excluir residencias cuando sean necesarias.

12.6 Reformar pensiones con enfoque de equidad generacional

Las reformas deben ser graduales, actuarialmente transparentes y distributivamente evaluadas. Deben ampliar cobertura, reducir privilegios, proteger pensiones mínimas y reconocer trayectorias de cuido y trabajo informal.

12.7 Construir una política migratoria de integración

La migración puede moderar la reducción de la fuerza laboral. Se requiere regularización eficiente, reconocimiento de capacidades, acceso a seguridad social e integración territorial. No debe tratarse como sustituto de las políticas de empleo y productividad.



13. Sistema de seguimiento propuesto

Un tablero demográfico debe distinguir hechos observados, estimaciones y proyecciones. Las revisiones deben conservar versiones anteriores para explicar cambios y evitar que una nueva serie borre la historia de decisiones tomadas con información previa.

Indicador	Línea base	Dirección de política	Frecuencia
Tasa global de fecundidad	1,12 (2024)	Derechos reproductivos y brecha deseada-realizada	Anual
Nacimientos	45.821 (2024)	Escenarios territoriales y de servicios	Anual
Población 0-11	745.349; 14,4% (2025)	Mejorar calidad y equidad por niño	Anual
Población 12-34	1,84 millones; 35,5%	Reducir exclusión educativa y laboral	Anual
Población 35-64	2,00 millones; 38,5%	Formalidad, productividad y salud	Anual
Población 65+	605.849; 11,7%	Cobertura económica y autonomía	Anual
Población 80+	130.055; 2,5%	Planificar cuidados de larga duración	Anual
Mortalidad infantil	10,21 por mil (2024)	Retomar tendencia descendente	Anual
Esperanza de vida	80,9 años (2024)	Más años de vida saludable	Anual
Edad mediana	33,9 años (2025)	Ajustar planificación sectorial	Anual
Índice de envejecimiento	62,2 (2025)	Preparar aceleración 2030-2050	Anual
Cobertura de cuidados	Oferta fragmentada	Metas y financiamiento plurianual	Semestral

El tablero debe actualizarse anualmente y presentar desagregaciones por sexo, territorio, nacionalidad, condición socioeconómica y discapacidad cuando la calidad de los datos lo permita. Para mortalidad deben publicarse tasas brutas y estandarizadas. Para centenarios se debe distinguir conteo registral, residencia habitual y proyección.

14. Conclusiones

Costa Rica envejece porque logró que más personas sobrevivieran y porque las familias tienen menos hijos. La longevidad es un éxito social; la fecundidad baja contiene dimensiones de libertad y desarrollo. El problema no es la transición en sí, sino la velocidad con que ocurre y la lentitud de la adaptación institucional.

En 1994 casi siete de cada diez habitantes tenían menos de 35 años. En 2025 esa proporción se aproxima a la mitad. La población de 35 a 64 se volvió el principal soporte productivo y la de 65 y más crece aceleradamente. Para 2050, una de cada cuatro personas podría tener 65 años o más y el número de personas de 80 años y más sería casi catorce veces el de 1994.

Las alertas no son nuevas. Los Informes identificaron caída de fecundidad, envejecimiento, presión sobre pensiones y salud, necesidad de cuidados y fin del bono con años de anticipación. Algunas



respuestas institucionales comenzaron, pero no alcanzan la escala requerida. La verificación retrospectiva muestra que el mayor riesgo ha sido tratar las advertencias como problemas futuros hasta que se convierten en restricciones presentes.

La estrategia correcta no enfrenta generaciones. La sostenibilidad de la vejez depende de invertir hoy en niñez, juventud y población trabajadora. A su vez, un sistema de pensiones, salud y cuidados protege a las familias jóvenes de asumir costos imposibles. La política demográfica debe construir un pacto intergeneracional basado en productividad, formalidad, corresponsabilidad y derechos.

Referencias documentales

Programa Estado de la Nación. *Primer Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible*. Edición referida a 1994. Capítulos sobre equidad, salud y compendio estadístico.

Programa Estado de la Nación. *Noveno Informe Estado de la Nación*. 2003. Capítulo de equidad e integración social, sección sobre fecundidad de reemplazo, esperanza de vida y mortalidad infantil.

Programa Estado de la Nación. *Décimo Informe Estado de la Nación*. 2004. Capítulo de equidad e integración social, recuadro sobre longevidad de personas adultas mayores.

Programa Estado de la Nación. *Decimocuarto Informe Estado de la Nación*. 2008. Sinopsis y recuadro sobre actualización de estimaciones y proyecciones de población.

Programa Estado de la Nación. *Decimoquinto Informe Estado de la Nación*. 2009. Capítulo de equidad e integración social, secciones sobre fecundidad territorial y mortalidad infantil.

Programa Estado de la Nación. *Decimonoveno Informe Estado de la Nación*. 2013. Capítulo de equidad e integración social, sección sobre envejecimiento y demanda de servicios de salud.

Programa Estado de la Nación. *Informe Estado de la Nación 2021*. Sinopsis, análisis del fin del bono demográfico y efectos de la pandemia sobre mortalidad y esperanza de vida.

Programa Estado de la Nación. *Informe Estado de la Nación 2025*. Capítulo 2, “Equidad e integración social”, pp. 111-119, envejecimiento, cuidados y servicios para personas adultas mayores.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. *Estimaciones y proyecciones nacionales de población 1950-2100 por sexo y edad*. Kit de resultados, actualización publicada en 2024 y archivo disponible en la plataforma institucional.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. *Indicadores demográficos 2024*. Resultados definitivos publicados en noviembre de 2025: población, nacimientos, fecundidad, reproducción y mortalidad.



Anexo metodológico: indicadores de referencia

Año	Población (mill.)	0-11 %	12-34 %	35-64 %	65+ %	EVN	TMI
1994	3,40	30,1	40,3	24,5	5,0	76,5	12,9
2004	4,16	23,7	40,9	29,5	5,9	78,5	9,5
2014	4,77	19,1	40,3	33,0	7,6	80,1	8,1
2024	5,16	14,9	36,0	38,0	11,2	80,9	10,2
2025p	5,19	14,4	35,5	38,5	11,7	81,0	7,2p
2030p	5,30	11,7	33,4	40,5	14,4	81,7	6,4p
2050p	5,41	9,2	22,1	43,8	24,9	84,3	3,7p

Nota: p = proyección; EVN = esperanza de vida al nacer; TMI = mortalidad infantil por mil nacimientos. Para 2024 se usa la cifra vital definitiva del INEC.

La tabla combina estimaciones históricas y proyecciones de estructura por edad del kit INEC con hechos vitales observados. Para 2024, los nacimientos, natalidad, fecundidad, reproducción y mortalidad corresponden a resultados definitivos; la estructura por edades es una estimación. Los escenarios 2030 y 2050 no son predicciones exactas, sino resultados condicionados por supuestos de fecundidad, mortalidad y migración.



The logo for the University of California, Riverside (UCR). It features the letters "UCR" in a white, serif font, positioned above a thin white horizontal line. The logo is centered on a background of overlapping blue geometric shapes.

UCR